



DIARRREA AGUDA INFECCIOSA (GEAI)

**Guía de Estudio Rápida y Algoritmos
Clínicos. Proyecto BADBEAR.MED.**



Síguenos en: Facebook | Instagram | YouTube | Rutube | OnlyFans | Telegram | TikTok

Definición y Enfoque Clínico

GEAI: ≥ 3 deposiciones anormales en 24 horas, duración < 14 días.
(Impacto: 1.700 millones de episodios/año globalmente).

Paso 1: Confirmar

Asegurar que es GEAI (no crónico, no extradigestivo).

Paso 2: Severidad

Evaluar grado de deshidratación (amenaza vital).

Paso 3: Etiología

Distinguir la causa probable para dirigir el tratamiento.



Evaluación Clínica: Grados de Hipovolemia

Signos	Leve (<5%)	Moderada (5-10%)	Grave (>10%)
Estado mental	Alerta	Inquieto/irritable	Letárgico
Ojos	Normal	Hundido	Muy hundido/seco
Sed	Aumento de sed	Bebe con avidez	No puede beber
Pellizco de piel	Vuelve rápido	Vuelve lentamente	Regresa muy lento (acampando)
Déficit estimado	<50 ml/kg	50-100 ml/kg	>100 ml/kg



Diarrea Acuosa Aguda: Diagnóstico Visual

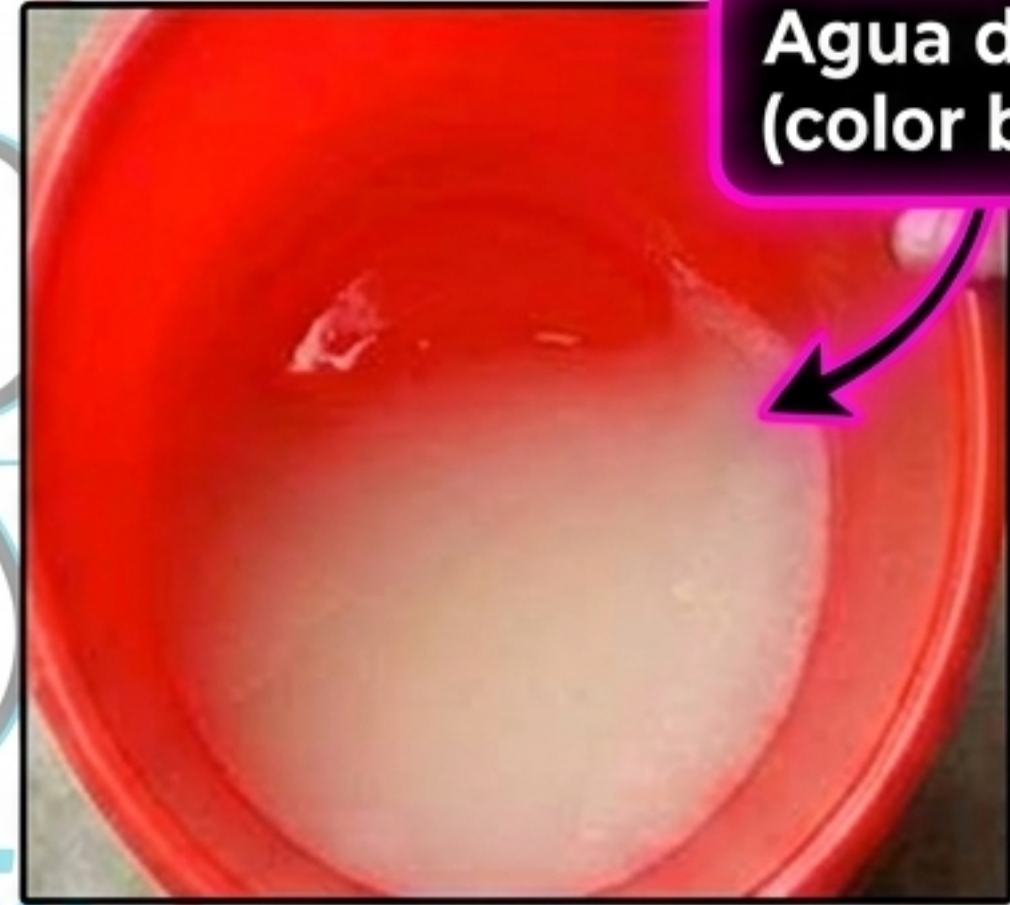
<14 días de duración, sin sangre visible.

Heces acuosas y verdes.



Frecuente en Rotavirus

Agua de arroz (color blanco).



Cólera Grave



Síguenos en: Facebook | Instagram | YouTube | Rutube | OnlyFans | Telegram | TikTok

Diarrea del Viajero: Epidemiología

Comienza durante o hasta 14 días después de viajar a zonas de sanidad limitada.

#1 ETEC (*Escherichia coli* enterotoxigénica) **17-70%**
(Mayor frecuencia global)

#2 *Shigella* spp. **2-30%**

#3 *Salmonella* spp. **1-16%**

Perla: En el Perú, *Cyclospora cayetanensis* es frecuente en balnearios de verano.



Síguenos en: Facebook | Instagram | YouTube | Rutube | OnlyFans | Telegram | TikTok

Toxiinfección Alimentaria: Matriz por **Período de Incubación**

Inicio Rápido (1-6 horas)

Toxinas Preformadas (Principalmente vómitos)

***S. aureus*:** Jamón, pollo, mayonesa, ensalada de papas.

***Bacillus cereus*:**
Arroz frito.

Inicio Tardío (>16 horas)

Virus / Bacterias (Predomina diarea e inflamación)

***E. coli* enterotoxigénica:**
Ensaladas, agua, queso.

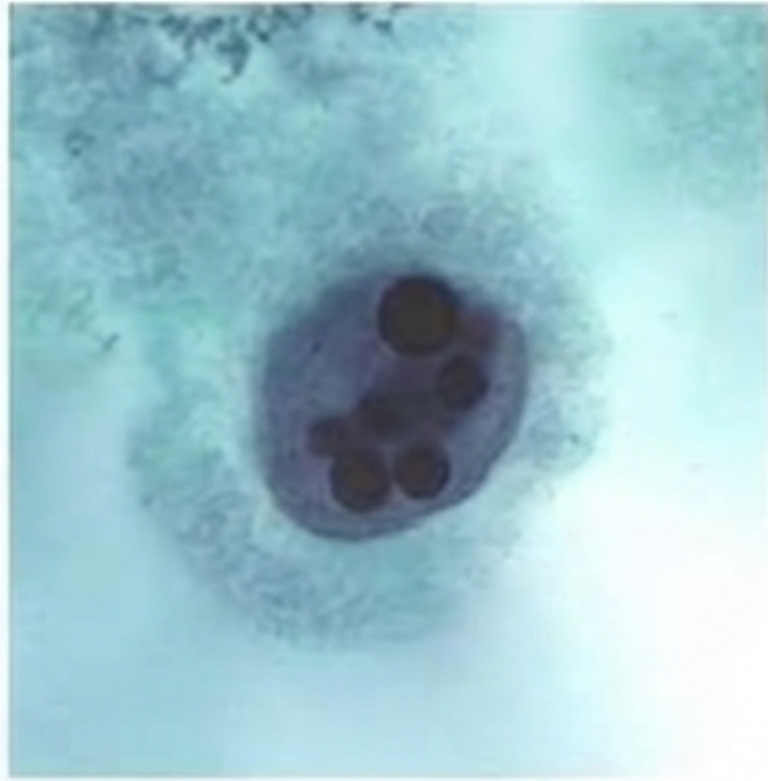
***Vibrio cholerae*:**
Mariscos.

***Salmonella* / *Campylobacter*:**
Pollo, lácteos, huevos.



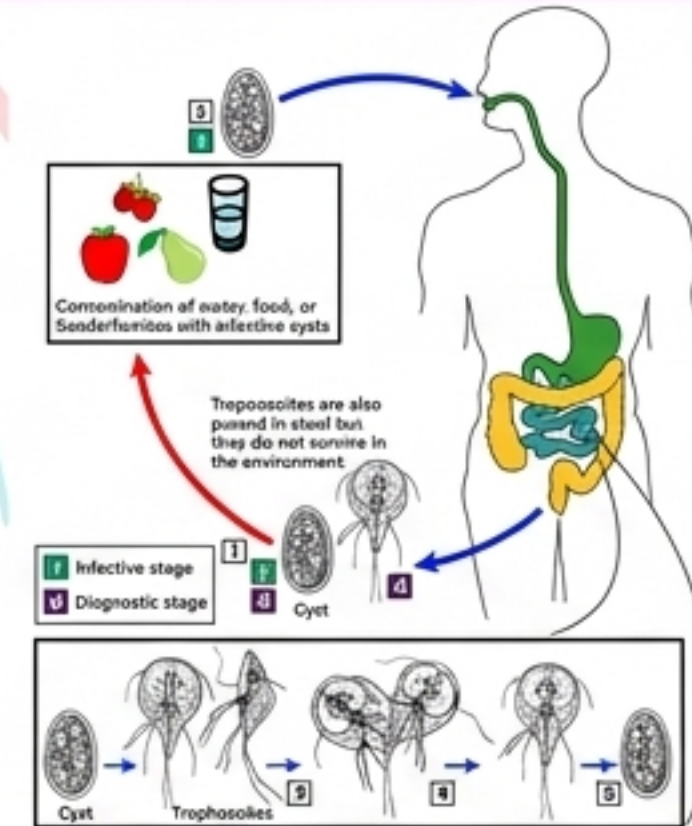
Parasitología I: **Entamoeba** vs. **Giardia**

Entamoeba histolytica



- **Diarrea inflamatoria/disentería.**
- **Trofozoítos con eritrocitos ingeridos.**
- **Alterna con constipación.**

Giardia lamblia



- **Diarrea acuosa, brillante, esteatorrea (grasosa).**
- **Flatulencia, distensión postprandial.**
- **Frecuente por agua cruda o guarderías.**

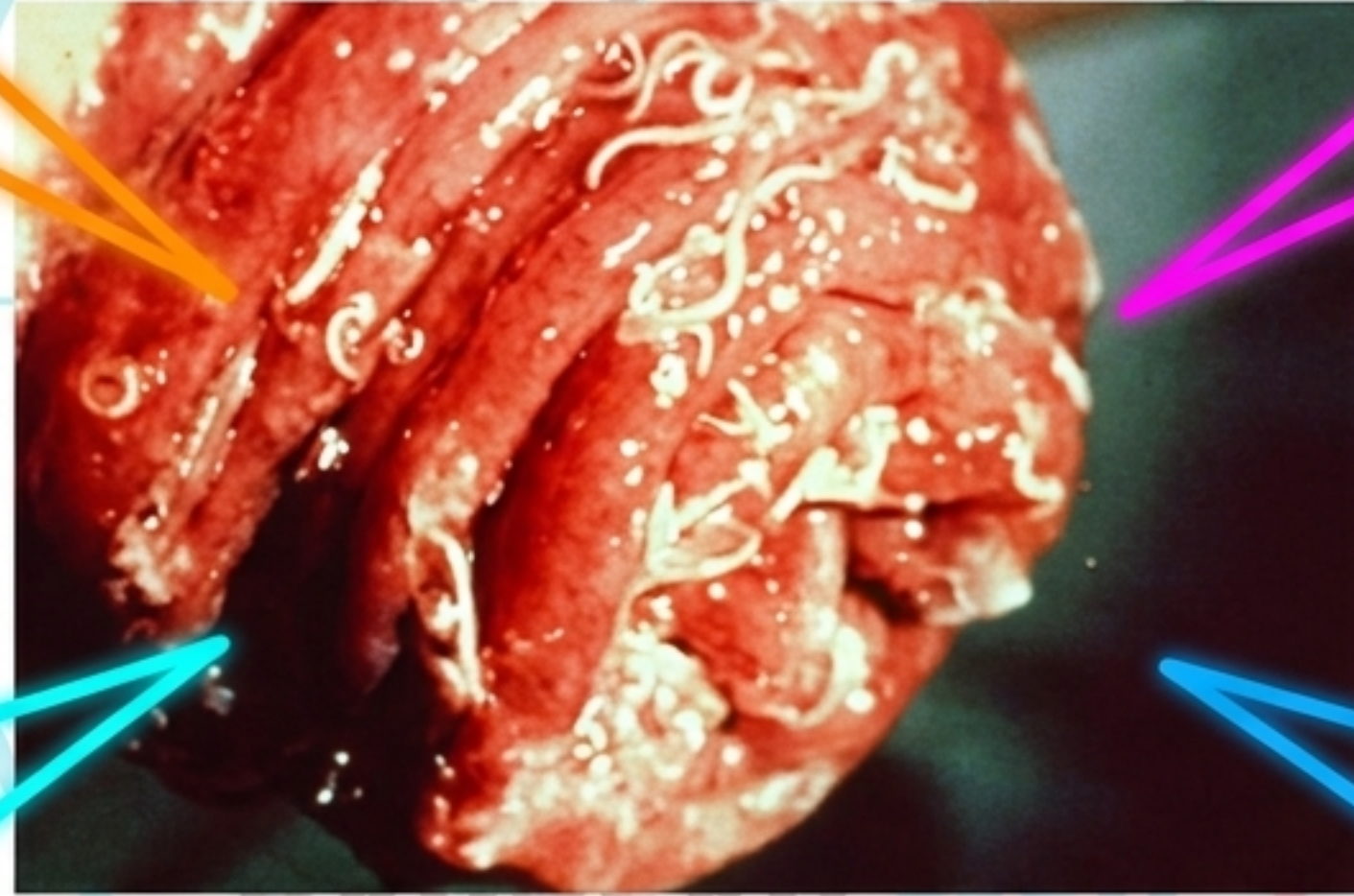


Parasitología II: Trichuriasis

Signo Patognomónico:
Prolapso rectal con
gusanos incrustados
en la mucosa.

Clínica Grave:
Disentería
(moco/sangre),
anemia secundaria.

Población: Niños con
retraso en el
crecimiento, pica,
dedos en palillo de
tambor.



Laboratorio:
Eosinofilia
periférica
(hasta 15%).



Síguenos en: Facebook | Instagram | YouTube | Rutube | OnlyFans | Telegram | TikTok

Terapéutica Dirigida: Manejo del Cólera

Mayores de 8 años y Adultos

1ra línea: Doxiciclina (300 mg VO, dosis única).

2da línea: Azitromicina (1g VO, dosis única).

Menores de 8 años

1ra línea: Azitromicina (20 mg/kg VO, dosis única).

Alternativa: Eritromicina.

Embarazadas / Lactancia

Elección: Azitromicina (1g VO, dosis única).



Terapéutica: Viajero y Clostridium difficile

Diarrea del Viajero

Azitromicina: 1000 mg única (De elección si hay disentería, fiebre o embarazadas).

Rifaximina: 200 mg x3/día (No usar si hay disentería).

Fluoroquinolonas (Cipro/Levo): Alta tasa de resistencia global, asociadas a eventos adversos.

Clostridium difficile

Episodio Inicial (Leve a Moderada):

Metronidazol (500 mg VO x3/día x 10-14 días).

Grave o sin respuesta:

Vancomicina (125 mg VO x4/día).



Perlas Clínicas de Estudio (1/3)

Caso:

Niño 5 años, disentería, palidez, dolor periumbilical, presenta prolapso rectal.

Clave:

Trichuriasis.

Caso:

Primer episodio leve-moderado de colitis por C. difficile post-antibióticos.

Clave:

Metronidazol.

Caso:

Niño en guardería, diarrea brillante/grasosa (esteatorrea), alterna con estreñimiento.

Clave:

Giardia lamblia.



Síguenos en: Facebook | Instagram | YouTube | Rutube | OnlyFans | Telegram | TikTok

Perlas Clínicas de Estudio (2/3)

Caso: Consumo de agua cruda → diarrea clara, grasosa, epigastralgia.

Clave: *Giardia lamblia*.

Caso: Vómitos, oliguria, diarrea en agua de lavado de arroz.

Clave: *Vibrio cholerae*.

Caso: Esquema antimicrobiano de primera elección para cólera en ADULTOS.

Clave: Doxiciclina.

Caso: Diarrea alterna con constipación, heces con trofozoítos y eritrocitos ingeridos.

Clave: Metronidazol (para *E. histolytica*).



Perlas Clínicas de Estudio (3/3)

Caso: Viajero con diarrea, moco, sangre y tenesmo.
Agente más frecuente en LATAM.

Clave: Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC).

Caso: Patógeno globalmente más frecuente en diarrea del viajero.

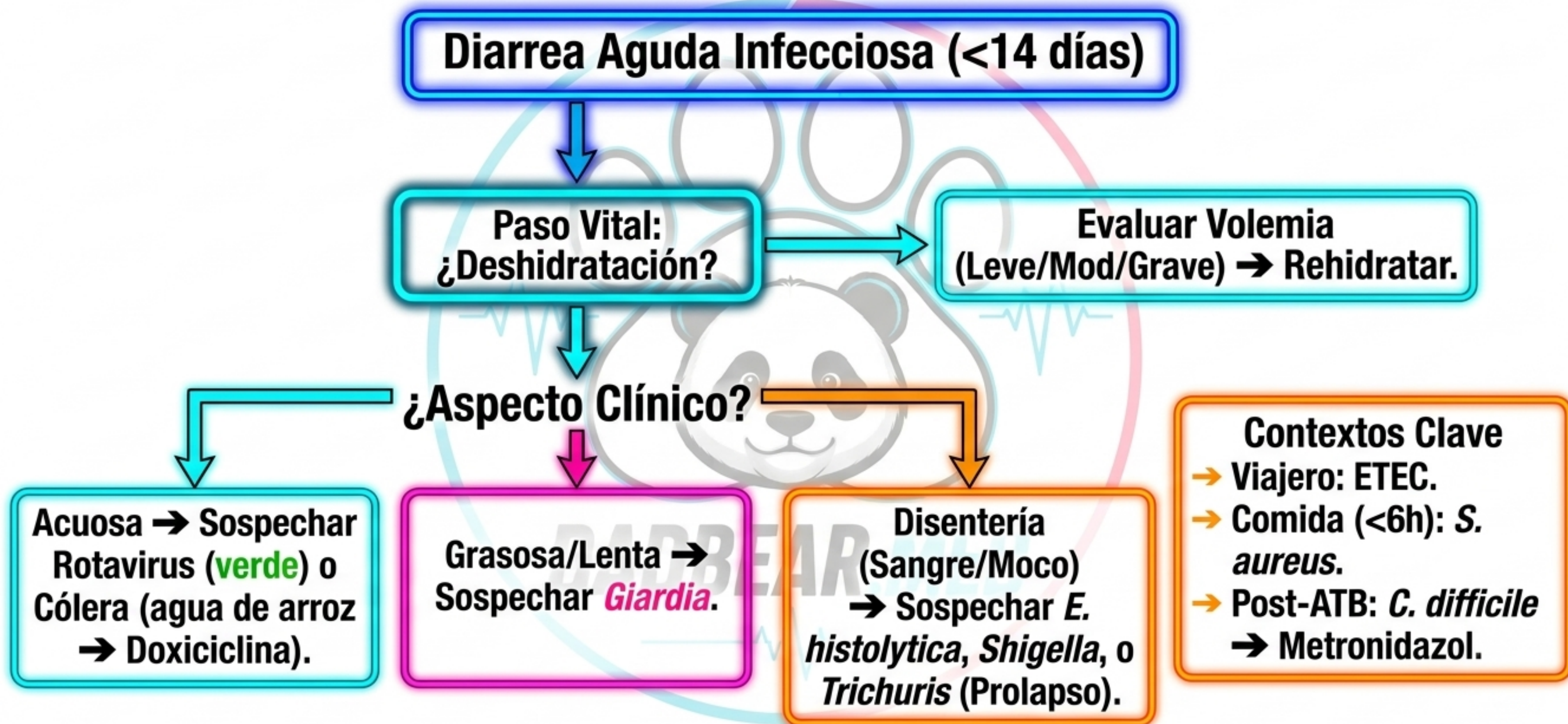
Clave: Escherichia coli.

Caso: 5-6 horas post-excursión (mayonesa/pollo), vómitos severos, sin fiebre.

Clave: Staphylococcus aureus (Toxina preformada).



Algoritmo **BADBEAR.MED**: Síntesis Diagnóstica





¡Domina la Clínica con BADBEAR.MED!

**Únete a la comunidad médica más disruptiva
para más algoritmos, perlas y guías visuales.**

Síguenos en:  Facebook |  Instagram |  YouTube |  Rutube |  OnlyFans |  Telegram |  TikTok